



ЛІКАРНЯ
ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ
ОНКОЛОГІЇ

Відділення променевої діагностики

Позитронно-емісійна томографія об'єднана із комп'ютерною томографією із 18F-ФДГ

Пацієнт Жерліцина Анастасія Станіславівна

ID 110889

Дата народження 25-04-1976

Дата дослідження 14-03-2024

Методика дослідження

Проведено ПЕТ/КТ сканування від рівня орбіт до середини стегон через 60 хвили після внутрішньовенного введення 10.9 мКі 18F-ФДГ. Рівень глікемії перед введенням РФП - 5.7 ммоль/л.

КТ сканування проведено із внутрішньовенним контрастуванням. Проведено додаткове сканування на рівні грудної клітки із затримкою дихання. Загальна DLP 1497 mGy*cm.

Корекція аттенуації ПЕТ зображень проведена на основі КТ даних.

Стандартизовані показники накопичення РФП нормалізовані за вагою пацієнта (SUV).

Мета дослідження/клінічні дані

Контрольна радіологічна оцінка після проведеного лікування

Дані попередніх досліджень для порівняння/кореляції

ПЕТ-КТ з ФДГ 17-08-2023, 11-04-2023

Знахідки

Голова та шия

Як і при попередній візуалізації, гіперметаболических змін типових для метаболічно активного агресивного неопластичного ураження не знайдено; без суттєвої динаміки, немає тромбів та аневризм великих судин.

Місце провадження діяльності:
08720, Київська обл., Обухівський район,
с. Плюти, вул. Малишка, 27

Юридична адреса:
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 77

ТОВ "Медікс-рей Інтернешнл Груп"
ЄДРПОУ 32109302, ІПН 321093026557
IBAN UA50 380838 00000 26006700394119 в АТ «Правекс банк» МФО 380838
IBAN UA19 305299 00000 26000026804357 в АТКБ «Приватбанк» МФО 305299
IBAN UA88 380805 00000 26004702687726 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805

тел.: 0 800 500 110
(Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України)
тел.: +38 (044) 277 8 277
факс: +38 (044) 520 94 01
www.lisod.ua



ЛІКАРНЯ
ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ
ОНКОЛОГІЇ

Грудна клітка

Як і при попередній візуалізації, гіперметаболических змін типових для метаболічно активного агресивного неопластичного ураження не знайдено; попередньо візуалізовані дрібні легеневі вузлики стабільні, також і ті дуже дрібні, що з'явилися при попередній візуалізації; нових активних/підозрілих легневих вузлів не знайдено. Елементи тимусу, до 23 мм товщиною, мають солідно-жирову структуру та лямбдоподібну конфігурацію, демонструють помірну дифузну активність, без окремих гіперметаболических вузлів, без динаміки.

Живіт і таз

Відомі маси в печінці як і при попередній візуалізації не демонструють істотної активності чи появи нових периферичних солідних компонентів, частина зменшила свої загальні розміри, домінуюча у правій частці з 16 до 15 см, у лівій частці з 5,0 до 4,5 см.

Нових гіперметаболических осередкових уражень в паренхімі печінки не знайдено.

Відома маса з стінки шлунку також і зараз без активних солідних компонентів, не демонструє підвищеного накопичення ФДГ, також і зменшилася з 44 до 40 мм.

Знову зменшилися неактивні маси у матці, наприклад, відносно

краніальніша/найбільша з 96 до 78 мм, як і при попередній візуалізації, демонструють низьку активність, структура їх без динаміки.

В іншому, без істотної динаміки, нових активних/підозрілих уражень не знайдено.

Кістки та м'які тканини

Як і при попередньому дослідженні, гіперметаболических кісткових уражень не знайдено, агресивних за структурними/КТ ознаками кісткових уражень не знайдено, без динаміки.



ЛІКАРНЯ
ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ
ОНКОЛОГІЇ

Радіологічний висновок

Порівняно із 08/2023, невелике зменшення неактивних залишків мас печінки та шлунку. Легеневі вузлики стабільні, неактивні вузли в матці що періодично коливаються в розмірах наразі менші.

Нових активних/підозрілих уражень не знайдено.

Загалом - радіологічно стабільна картина, зараз немає метаболічно активних компонентів.

З повагою, Новіков М. Є.

лікар радіолог,

завідувач відділенням променевої діагностики

Лікарні Ізраїльської Онкології LISOD